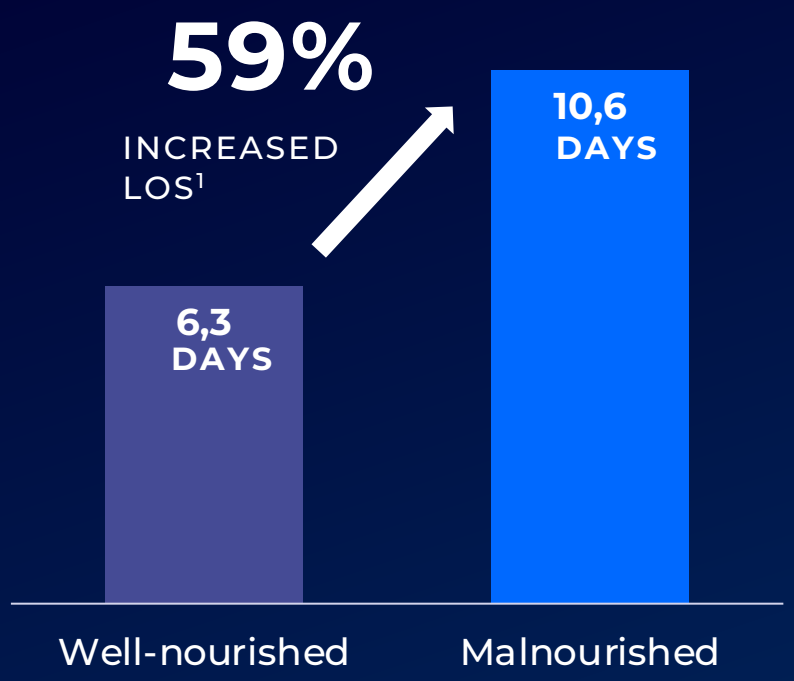
Optimisation de la gestion nutritionnelle dans le parcours de soins

Co-Création
Vivalia/Dim3

Dim3
See detail from global



Coût global de la malnutrition cliniqque



UNTREATED MALNUTRITION COSTS

€170B

per year in EU[2]

Augmentation Longueur de Séjour (LOS)

Augmentation cout des services de santé

1. https://clinicalnutritionespen.com/article/S2405-4577(15)00097-2/pdf
2. https://www.nature.com/articles/ejcn2014280

Dim3

L'Ecosysteme DIM3

360° Clinical Nutrition Management System

FROM HOSPITAL→ HOME



Dim3
See detail from global



L’Ecosysteme DIM3

360° Clinical Nutrition Management System

FROM HOSPITAL→ HOME



Dim3
See detail from global

IMPACTS

Augmentation compliance nutritionnelle :
De 60% à plus de 90% en entérale

Suivi spécifique patient dans son parcours de soin

Travail d’équipe nutritionnelle plus efficace – temps et gestion

Tracabilité 100%

Meilleur remboursement par RHM documenté

Qualité percue de l’établissement

Activités Dim3



UTILISATEURS

Belgique : CHU Lg ICU
France : CHU Lille ICU + ESSAI CLINIQUE

Dim3 Membre différents groupes de travail (ONCA/SNBC)

EN COURS

PedoPsychiatrie
Italie : Homecare

PROJET / HISTORIQUE

2/2022

Discussion potentielle collaboration

Bras Clinique

Bras Financier

Analyse impact Dim3 sur remboursement

Lettre d'intention 2/23

Financement Via Wallonie Santé

RBSMT MAJORE DE PLUS D'UN MILLION

ADHESION RESPONSABLE NUTRITION

COMPATIBILITE IT VERIFIEE

11/2023

Dossier introduit chez WS

615.000 €
7 ans

50% WS

50% ING

Analyse impact Dim3 sur gestion de la Nutrition patientele et augmentation remboursements

Dim3

FINANCES



ENTREES

Minimum 700.000 euros environ/an d'augmentation de remboursement

Efficience gestion Nutritionnelle augmentée

SORTIES
(2 exercices)

615.000 €

390.000 prestations Dim3 euros documentée sans prise benefice

225.000 equivalents prestations personnel Vivalia
+ Connecteur Zorgi

Durée 15 mois

FINANCEMENT

Pret Wallonie Santé et ING Santé

7 ans

Vivalia + DIM3 / Structure projet



ETAPES PHASE 1

1. Définition mode d'organisation et organes de supports et controles
2. Analyse intensive de l'impact économique sur les remboursements
3. Intégration produits DIM3 soins intensifs avec connecteur Metavision
4. Connecteurs Vivalia (DPI / DII / LIMS/ Pharmacie) des produits Dim3
5. Le faire dire, le faire savoir
6. Rapports utilisation du produit (USABILITY) / impact financier Vivalia / points améliorer et innover

Durée 15 mois

Equipes projet (proposition)



Comité de Pilotage

Direction Générale – Vivalia
Direction Médicale - Vivalia
Direction Financière – Vivalia
Arnaud Lallemand - CEO
Jean-Claude Havaux - CSIO
Ghislain Lacrosse - BDMgr

1x / trimestre

Comité Projet



Médecin Soins Intensifs
Diététicien.ne
Thomas Debiève
Représentant RHM
Christèle Freychet
Thierry Keutgen

1x / mois



Equipe intégrée Pratique Clinique

Médecins Soins Intensifs
Infirmiers.ères
Diététicien.ne
Christèle Freychet
Manon Moreau



Equipe intégrée RHM

Représentant(s) Vivalia
Manon Moreau

1x / semaine



Equipe intégrée IT

Thomas Debiève
Services IT
Christèle Freychet
SW Developers



Comité scientifique

Représentant(s) Vivalia
Christèle Freychet

1x / trimestre

*Chaque équipe pourra demander la participation d'autres personnes-experts en fonction des sujets. Les chefs de projet sont en **gras***

Dim3

Vivalia + DIM3





PHASE 2 ?

1. Amélioration produits dim3 suite aux recommandations phase 1
2. Préparation des architectures IT pour extension hors hôpital
3. Intégration Dim3 Cuisine / Homecare / Maison de repos

Vivalia + DIM3 / DELIVRABLES





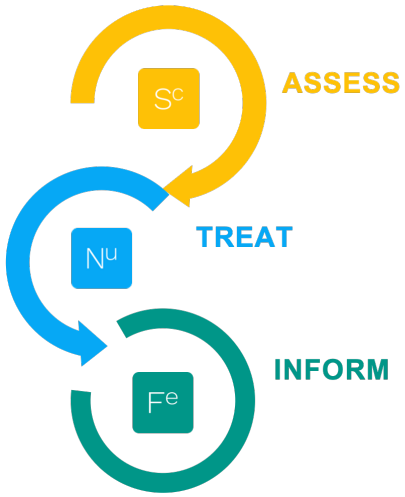
- Version multi-site à 360° / RHM Automatisation
- Vivalia centre de référence Dim3
- Communication internationale sur la collaboration
- Publication scientifique avec notre comité scientifique
- Tarification de notre portefeuille à prix coûtant pendant X ans
- Dissémination autres hôpitaux
- Démarrage principe de demande de remboursement INAMI avec référence Vivalia

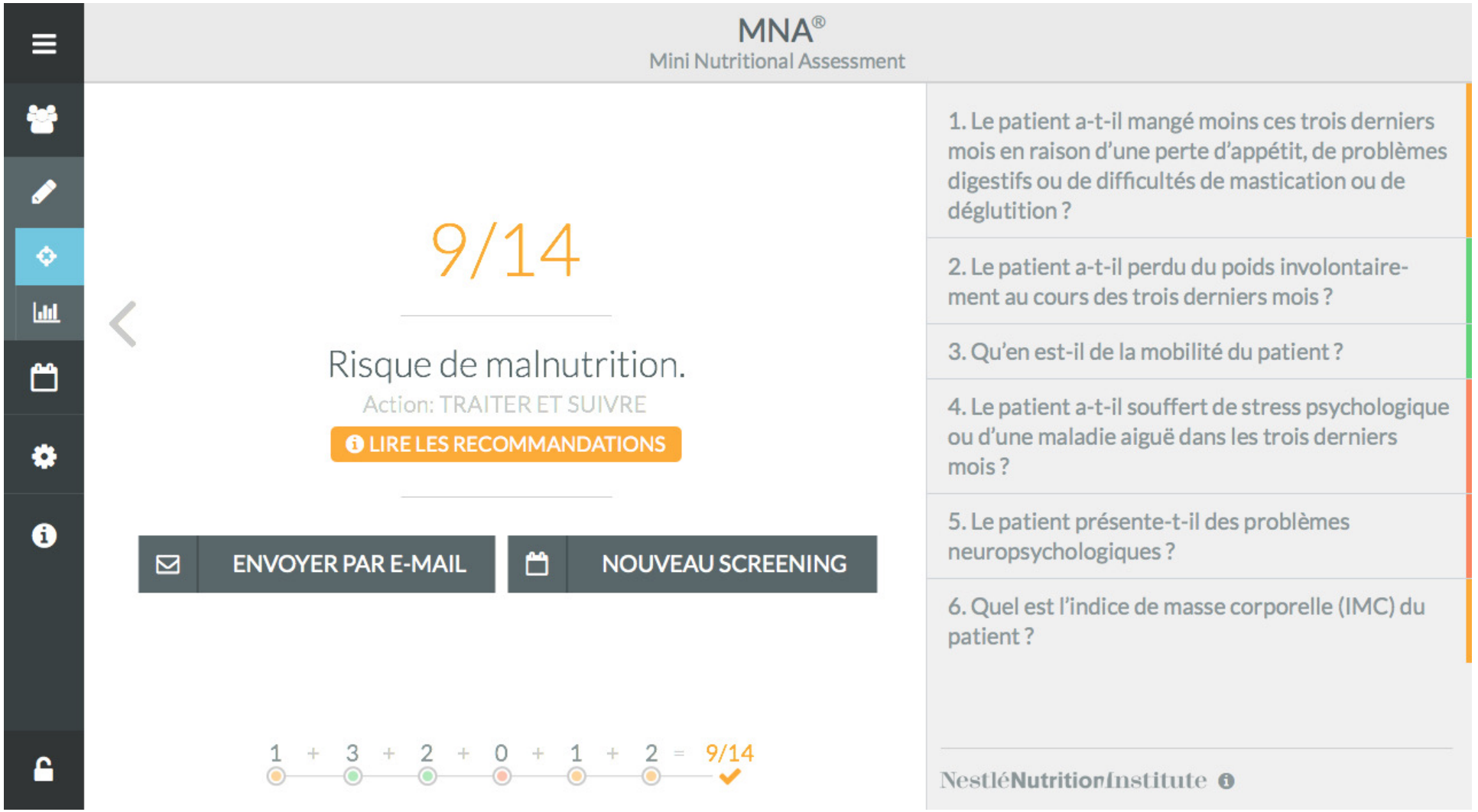
Merci

JEAN-CLAUDE HAVAUX
JC.HAVAUX@DIM3.COM
TELEPHONE: +32 475704830
www.dim3.com

Dim3
See detail from global

Scorso


Sc
ASSESS
Nu
TREAT
Fe
INFORM


MNA®
Mini Nutritional Assessment
9/14
Risque de malnutrition.
Action: TRAITER ET SUIVRE
LIRE LES RECOMMANDATIONS
ENVOYER PAR E-MAIL
NOUVEAU SCREENING
1 + 3 + 2 + 0 + 1 + 2 = 9/14
1. Le patient a-t-il mangé moins ces trois derniers mois en raison d'une perte d'appétit, de problèmes digestifs ou de difficultés de mastication ou de déglutition ?
2. Le patient a-t-il perdu du poids involontaire-ment au cours des trois derniers mois ?
3. Qu'en est-il de la mobilité du patient ?
4. Le patient a-t-il souffert de stress psychologique ou d'une maladie aiguë dans les trois derniers mois ?
5. Le patient présente-t-il des problèmes neuropsychologiques ?
6. Quel est l'indice de masse corporelle (IMC) du patient ?
NestléNutritionInstitute

Default

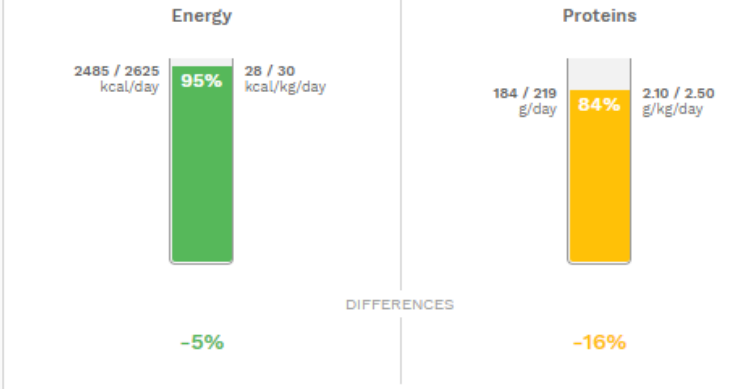
CONFIGURE

Patient info

Name	Satordi Barrientos
Sex	Male
Age	59.5
Weight	94.0 kg
Temperature	36.5 °C
Body mass index	29.0 kg/m²
Water balance	-130.0 ml
Unit	IGB
Bed	B6

Requirements : targets & results

Yesterday

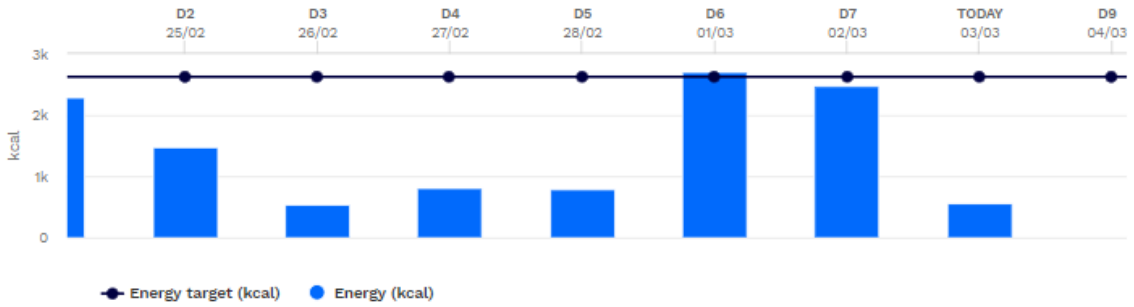


Lab analyses



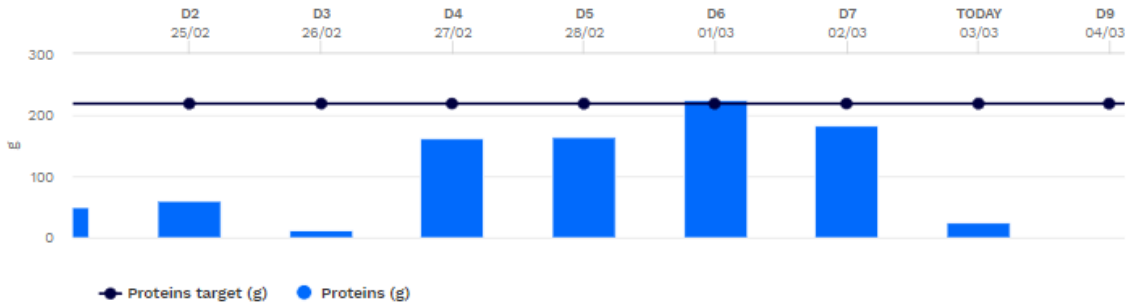
Energy - Targets vs Results

Last week



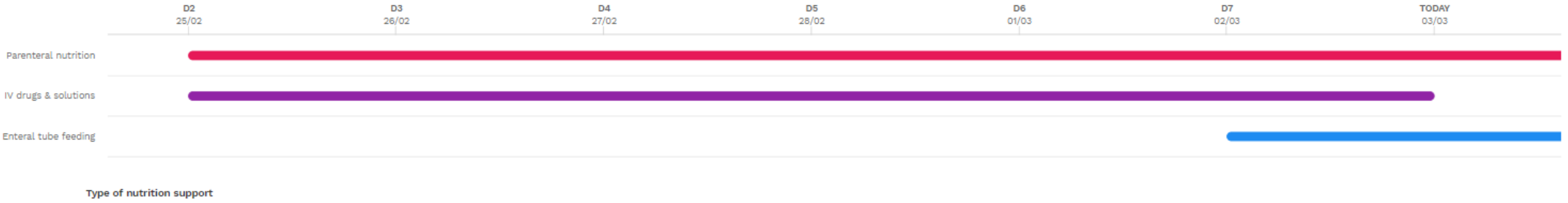
Proteins - Targets vs Results

Last week

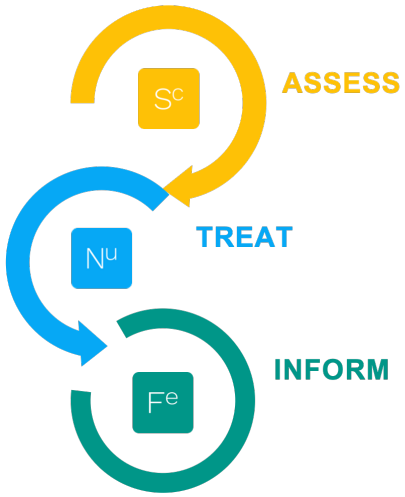


Feeding

Last week



Feedim





Dim3

The Virtuous Cycle of Better Nutrition

KPI from Scientific Literature and Society Recommendations

BETTER COMPLIANCE

91%

RX calories delivered to patients with computer-based decision support system[1]

SAVE TIME

68%

Less work time per patient with a nutrition management system[2]

REDUCE COSTS

€3.300+

Cost savings per malnourished patient on nutrition-focused program[3]

1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3667982/
2. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28975010/
3. https://www.clinicalnutritionjournal.com/article/S0261-5614(18)30201-2/fulltext

Benefits



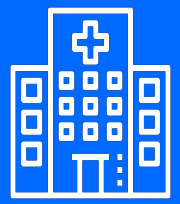
Patients

- Optimize Tx compliance
- Early prevention
- Individualized care
- Designed to improve outcomes:
  - ↑Survival
  - ↓ LOS
  - ↓ Readmissions
  - ↓ Admission to ICU



Nutritional Team

- Optimize workflow & team communication
- Centralize patient nutritional status
- Reduce errors associated with manual data entry
- Simulate optimal nutrition
- Adopt clinical guidelines
- Support scientific research with structured database



Hospital

- Evidence-based, 1st-class support
- Recognized cost savings
- Additional revenues by optimally documenting malnutrition
- Stimulate interdisciplinary/ inter-hospital dialogue
- Concrete building block for JCI/AC or other professional accreditation programs



Homecare Provider

- Better service and support
- Service differentiation
- Maximize compliance
- Accuracy of nutrition delivery
- Remote technical assistance
- Reduce unnecessary visits
- Efficient stock management

Root Causes of Malnutrition

Poor Detection

Patients at malnutrition risk are not detected or not detected soon enough

Lack of Knowledge

Professionals lack knowledge and sometimes interest in nutrition, resulting in non-optimal practices



Less than 60% Compliance[1,2]

Patients don't receive what they have been prescribed. Very few know the issue

Multi-step, Disconnected Care

Multiple in-hospital transitions, lack of coordination between hospital and home and the trend toward shorter LOS intensifies an issue that is already ill-addressed

1. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19572118/
2. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31684024/